

Alimentación complementaria

1. Introducción y relevancia clínica

La **alimentación complementaria (AC)** corresponde a la introducción de alimentos sólidos o semisólidos **en forma progresiva**, mientras se **mantiene la lactancia materna (LM)**. Su propósito es **satisfacer los requerimientos nutricionales** que la leche ya no cubre completamente después de los 6 meses, especialmente **energía, hierro, zinc y vitaminas**.

La introducción oportuna y adecuada de alimentos complementarios es crucial para:

- Prevenir **desnutrición, anemia ferropriva y deficiencia de micronutrientes**.
- Favorecer el desarrollo del gusto, la masticación y hábitos saludables.
- Prevenir la **obesidad y malnutrición por exceso** a largo plazo.

En Chile, la AC se enmarca en el **Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNIAC)**, el cual entrega alimentos fortificados (como **Purita cereal** y **Mi Sopita**) y orienta sobre la educación alimentaria familiar.

En el **EUNACOM**, este tema se evalúa mediante casos de lactantes en control sano donde se debe determinar el momento, tipo y consistencia de los alimentos a ofrecer o detectar errores comunes como la introducción precoz o tardía.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a. Maduración digestiva y neurológica

A los **6 meses**, el lactante alcanza el desarrollo fisiológico necesario para iniciar la alimentación complementaria:

Sistema	Cambios relevantes
Digestivo	Maduración enzimática (amilasa pancreática, lipasa, proteasas). Capacidad gástrica aumentada.

Renal	Mayor capacidad de excretar solutos, permitiendo procesar alimentos distintos a la leche.
Neurológico y motor	Control cefálico completo, desaparición del reflejo de extrusión, inicio de movimientos de masticación y deglución voluntaria.
Oral y social	Curiosidad por los alimentos, coordinación mano-boca y disposición al juego alimentario.

Estos hitos permiten una transición segura hacia alimentos sólidos sin riesgo significativo de aspiración ni intolerancia.

b. Concepto de alimentación complementaria

Definición:

Introducción progresiva de alimentos sólidos o semisólidos adecuados a la edad, junto con la lactancia materna continuada, desde los **6 hasta los 24 meses**.

No se trata de “sustituir” la leche materna, sino de **complementarla**.

c. Fundamentos nutricionales

A partir de los 6 meses, la leche materna **no cubre completamente las necesidades de energía, hierro y zinc**, por lo que los alimentos deben aportar estos nutrientes.

- **Requerimiento energético:** ~700 kcal/día (6–8 meses) y ~900 kcal/día (9–11 meses).
 - **Requerimiento proteico:** 1,2 g/kg/día.
 - **Hierro:** 11 mg/día → introducción temprana de alimentos ricos en hierro (carne, cereales fortificados).
 - **Zinc y vitaminas:** aportados por frutas, verduras y cereales integrales.
-

3. Clínica: indicaciones prácticas y progresión alimentaria

a. Edad de inicio

- OMS y MINSAL: 6 meses cumplidos.
- No se recomienda antes (riesgo de alergia, infección, obesidad) ni después (riesgo de déficit de hierro y zinc).

b. Principios generales

Principio	Descripción
Mantener lactancia materna	Continuar hasta los 2 años o más.
Inicio progresivo	Introducir un alimento nuevo a la vez, esperar 2–3 días entre cada uno.
Textura y consistencia	Según edad y desarrollo oral.
Variedad	Incluir todos los grupos de alimentos.
Autonomía y respeto	Fomentar el “alimentarse solo” (baby-led weaning con supervisión).
Higiene y seguridad	Lavado de manos, cocción adecuada, evitar contaminación.

c. Alimentos según edad y consistencia (MINSAL 2015)

Edad	Tipo de alimento	Consistencia	Frecuencia diaria
------	------------------	--------------	-------------------

6–8 meses	Purés de verduras, papas, cereales fortificados, carne picada, frutas molidas	Triturada / colada	2 veces al día + LM
8–12 meses	Comidas familiares adaptadas (picadas finas), legumbres sin piel	Molida / semisólida	3 veces al día + colación
12–24 meses	Alimentos de la dieta familiar	Sólida	4 comidas diarias + 1 colación

d. Alimentos específicos recomendados

Grupo	Ejemplos	Frecuencia
Cereales y tubérculos	Arroz, avena, maíz, papa, fideos	En cada comida
Verduras y frutas	De todos los colores	2–3 veces al día
Proteínas animales	Carne magra, pollo, pescado, hígado	Diario desde los 6 meses
Legumbres	Lentejas, porotos, garbanzos	Desde 8 meses, sin piel
Grasas saludables	Aceite vegetal crudo, palta	1 cucharadita por comida
Agua	Como bebida principal desde el inicio de AC	A libre demanda

e. Alimentos a evitar

Alimento	Motivo
Miel (<1 año)	Riesgo de botulismo infantil
Leche entera de vaca (<12 meses)	Déficit de hierro y sobrecarga renal
Sal, azúcar, condimentos fuertes	Riesgo renal y mal hábito alimentario
Jugos envasados, gaseosas, dulces	Riesgo de obesidad
Frutos secos enteros, uvas, trozos duros	Riesgo de asfixia

f. Signos de preparación del lactante para iniciar AC

- Sostiene la cabeza y se sienta con apoyo.
- Muestra interés por la comida y abre la boca al ofrecerle.
- Pierde reflejo de extrusión (no empuja el alimento con la lengua).
- Demuestra hambre y saciedad (voltea la cabeza, cierra la boca).

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

La evaluación de la alimentación complementaria se basa en la **observación clínica y el crecimiento**:

1. Crecimiento adecuado:

- Ganancia ponderal ≥ 150 g/semana en el primer semestre y ≥ 100 g/semana después.
- Mantención del canal de crecimiento (curvas OMS).

2. Valoración nutricional:

- Peso/talla e IMC según edad (curvas OMS).
- Vigilancia de anemia con **hemoglobina a los 12 meses** (según Norma MINSAL).

3. Evaluación de ingesta:

- Registro dietético o anamnesis alimentaria.
- Detección de errores frecuentes (introducción precoz, exclusión de grupos alimentarios).

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

El tratamiento o intervención educativa depende de la etapa y errores detectados.

a. Orientaciones principales del MINSAL

Edad	Recomendaciones
0–6 meses	Lactancia materna exclusiva.
6–24 meses	Introducir AC manteniendo LM; aumentar gradualmente variedad y textura.
>24 meses	Alimentación familiar saludable, limitar azúcar y sal.

b. Manejo de errores comunes

Error	Consecuencia	Corrección
-------	--------------	------------

Inicio antes de los 6 meses	Riesgo de alergia y obesidad	Retrasar hasta 6 meses
Retraso >8 meses	Déficit de hierro y anorexia selectiva	Introducir gradualmente con refuerzo positivo
Exclusión de carnes	Anemia ferropriva	Incorporar carnes rojas y fortificados
Uso de papillas licuadas prolongadas	Retraso en masticación	Ofrecer trozos blandos progresivamente
Uso de jugos o azúcar	Obesidad	Promover agua y frutas naturales
Forzar la alimentación	Conductas alimentarias adversas	Alimentación responsiva y respetuosa

c. Rol del equipo de salud

- **Pediatra:** evalúa crecimiento, corrige errores y supervisa nutrición.
 - **Nutricionista:** orienta cantidad, consistencia y frecuencia.
 - **Enfermera / matrona:** educación a padres, refuerzo en controles.
 - **Equipo de salud familiar:** promueve prácticas alimentarias saludables en comunidad.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Causa frecuente	Consecuencia
Anemia ferropriva	Falta de carnes o fortificados	Retraso del desarrollo, palidez, fatiga
Desnutrición	Introducción tardía o insuficiente	Déficit de crecimiento
Obesidad infantil	Introducción precoz, exceso de azúcar	Riesgo cardiovascular futuro
Trastornos de alimentación	Forzar comidas, ansiedad parental	Conductas restrictivas o selectivas

Con educación familiar y controles periódicos, el pronóstico nutricional es excelente.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

□ Perlas:

1. La **alimentación complementaria inicia a los 6 meses**, sin suspender la lactancia.
2. Los **alimentos ricos en hierro (carnes, cereales fortificados)** deben introducirse primero.
3. **Evitar miel, leche entera y azúcar antes del año.**
4. La **textura debe progresar** según la edad: papilla → molido → trozos blandos → sólidos.
5. La **alimentación responsiva (sin forzar)** previene rechazo y trastornos alimentarios.
6. **Agua es la única bebida recomendada**; no jugos ni té.
7. El **PNIAC** entrega alimentos fortificados (Purita cereal, Mi Sopita) para prevenir deficiencias.

❑ Errores frecuentes:

- Introducir papillas antes de los 4–5 meses.
 - Mantener purés licuados más allá del año.
 - Ofrecer jugos o postres azucarados.
 - No incluir proteínas animales.
 - No reforzar LM durante la AC.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **alimentación complementaria comienza a los 6 meses**, manteniendo la lactancia materna.
2. Debe ser **progresiva, variada, adecuada en textura y frecuencia**.
3. Iniciar con **alimentos ricos en hierro y zinc** (carnes, cereales fortificados).
4. **Evitar sal, azúcar, miel, leche entera y alimentos duros** durante el primer año.
5. La **alimentación responsiva y familiar** favorece el vínculo y hábitos saludables.
6. El **PNIAC** garantiza acceso a alimentos fortificados para lactantes.
7. Una **buena introducción alimentaria previene anemia, obesidad y rechazo alimentario**.